

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 파열되면 저절로 붙나요?

완전히 파열된 힘줄은 스스로 붙기 어렵습니다.
파열 크기·증상·기능을 함께 봅니다.

Q2 꼭 수술해야 하나요?

아닙니다. 부분 파열·작은 파열은 약물·재활 등
비수술 치료부터 시작할 수 있습니다.

Q3 오십견과 다른가요?

오십견은 관절이 굳는 질환이고 회전근개 파열은
힘줄 손상입니다. 함께 생길 수도 있습니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 외상 뒤 갑자기 팔을 들 수 없거나 힘이 크게 떨어짐
- 발열·붓어짐·심한 부종 또는 새로 생긴 팔·손 저림

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

증상·근력 검사·MRI를 함께 보고 파열 크기와 위
치, 힘줄과 근육 상태를 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 어깨 관절경

진찰과 영상을 직접 설명하고 비수술 치
료부터 관절경 봉합술까지 개인별 치료
범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 X-ray·초음파·MRI CD와 판독지
- 약물·주사·재활 등 치료 기록
- 외상 시점과 통증·근력 변화

대표 전화 031-328-0333

용인특례시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사 결과에 따라
달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

어깨 회전근개 파열

팔을 들 때 아프고 힘이 빠지는 어깨,
파열 크기와 힘줄 상태를 함께 확인합니다.

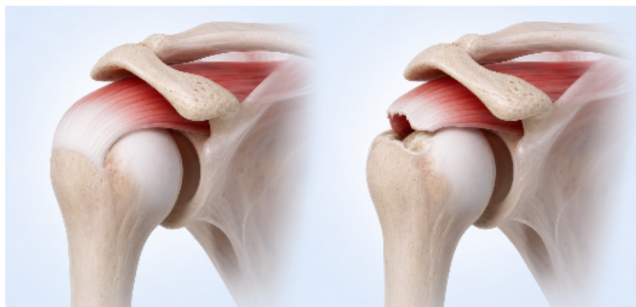


관절경 회전근개 봉합술

파열이면 무조건 수술하는 것이 아니라 통증·근력·기
능·영상과 치료 반응을 함께 보고 결정합니다.

01 질환·증상

회전근개는 어깨를 감싸 팔을 들고 돌리는 네 힘줄입니다. 퇴행·반복 사용·외상으로 부분 또는 전층 파열될 수 있습니다.



이런 증상을 확인합니다

- 팔을 들거나 머리 위 동작에서 통증
- 야간통과 아픈 쪽으로 눕기 어려움
- 팔 힘이 빠지거나 움직임이 제한됨

진단의 핵심

진찰로 근력·움직임을 보고 X-ray·초음파·MRI로 파열 크기·위치·퇴축과 근육 상태를 확인합니다.

02 치료 선택

증상·진찰·영상·치료 반응과 생활 목표를 함께 보고 치료 방향을 결정합니다.

먼저 해볼 치료

- 통증을 유발하는 활동 조절과 약물 치료
- 어깨 움직임과 주변 근육을 위한 재활
- 상태를 확인한 뒤 선택적으로 주사 치료

수술을 검토할 때

- 충분히 치료해도 통증·근력 저하가 지속될 때
- 급성 외상성 파열 또는 큰 전층 파열일 때
- 일상·직업·운동 기능 제한이 이어질 때

치료의 흐름

비수술 치료

>

증상·근력·영상
재평가

>

필요 시 수술

03 수술·회복

관절경 회전근개 봉합술



- 가 파열된 힘줄과 뼈 부착 부위를 확인
- 나 손상 조직을 정리하고 뼈 부착 면을 준비
- 다 봉합 나사못을 뼈에 고정하고 힘줄에 실을 통과
- 라 힘줄을 원래 부착 부위에 밀착해 고정

회복은 힘줄 치유에 맞춰

- 초기: 보조기·상처·통증 관리와 봉합 부위 보호
- 중기: 지시에 따라 수동 운동 뒤 능동 운동
- 후기: 근력 운동과 일상·운동 복귀를 단계적으로

알아둘 위험과 한계

감염, 관절 강직, 봉합 부위 재파열, 신경·혈관 손상, 잔여 통증, 마취 관련 합병증 등이 있을 수 있습니다.